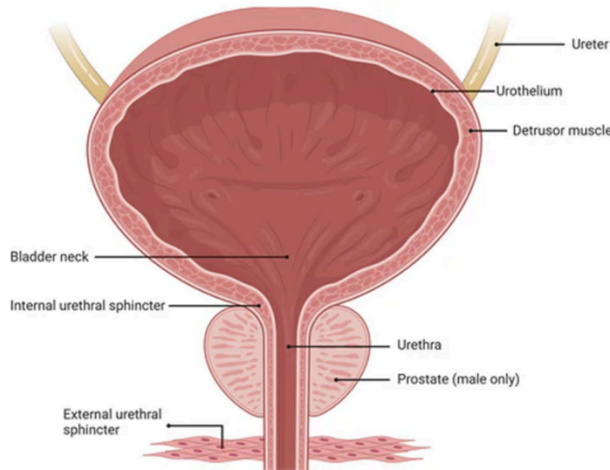
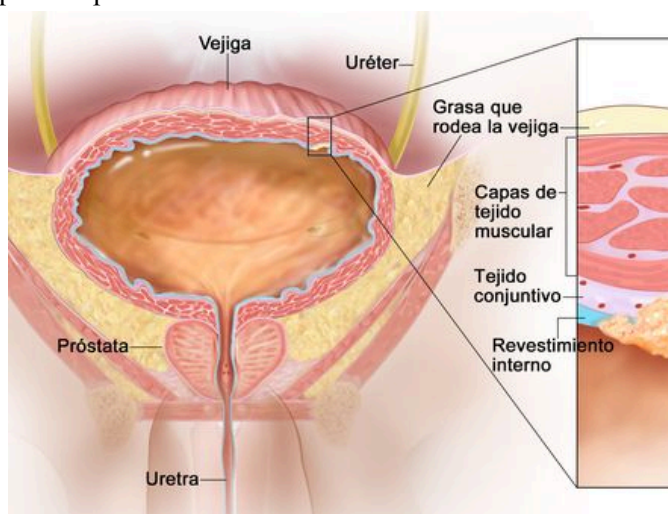




NOMBRE DEL ESTUDIANTE:		CÓDIGO:	NIVEL DE PRÁCTICA:
NOMBRE DEL DOCENTE : Samuel Palacio Peña		ESCENARIO DE PRÁCTICA:	NOTA:
ESPECIALIDAD: Urología	CIRUJANO:	FECHA:	
NOMBRE DEL PACIENTE:		NÚMERO HISTORIA CLÍNICA:	EDAD DEL PX:
PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO A REALIZAR: <i>CISTECTOMÍA TOTAL</i>			
PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA			
• ETAPA DE PLANEACIÓN:			
1.1. OBJETIVO QUIRÚRGICO: (HACER DESCRIPCIÓN) El objetivo quirúrgico es realizar la colocación de una cinta de malla sintética debajo de la uretra para proporcionar soporte adicional y prevenir la pérdida de orina.			
1.2. ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA: (HACER GRÁFICO Y DESCRIPCIÓN). ANATOMÍA  The diagram illustrates the male urinary system. At the top, two yellow tubes represent the ureters entering the bladder. The bladder is a large, sac-like organ with a thick, muscular wall. Labels point to the 'Ureter', 'Urothelium' (inner lining), and 'Detrusor muscle' (the muscular wall). The bottom of the bladder is the 'Bladder neck'. Below it is the 'Internal urethral sphincter'. The 'Urethra' is the tube that carries urine from the bladder. It passes through the 'Prostate (male only)' gland. At the very bottom, it exits through the 'External urethral sphincter'.			
La vejiga es un órgano muscular hueco y distensible, situado en la cavidad pelviana, por detrás de la sínfisis del pubis. En los hombres, se encuentra por delante del recto y en la mujer es anterior a la vagina e inferior al útero. Con una capacidad de la vejiga oscila en promedio entre 700 y 800 ML.			
La vejiga posee 3 porciones:			

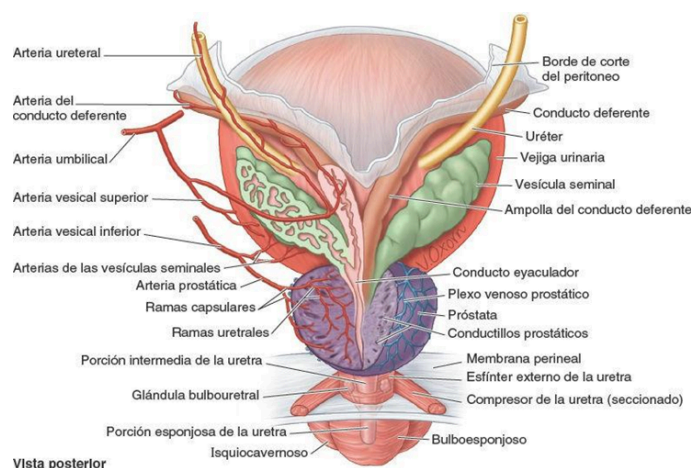
- o **Cuerpo:** Dónde la orina es recolectada.
- o **Fondo (Base):** Contiene al trigono vesical.
- o **Trígono Vesical:** Donde se localiza la uretra.

A su vez se compone por 3 capas:



- **Capa Serosa:** Se compone de tejido conectivo alveolar.
- **Capa Muscular:** Formada por 3 capas de fibras musculares lisas: Longitudinal interna, circular media, longitudinal externa.
- **Capa Mucosa:** Compuesta por epitelio de transición y una lámina propia subyacente.

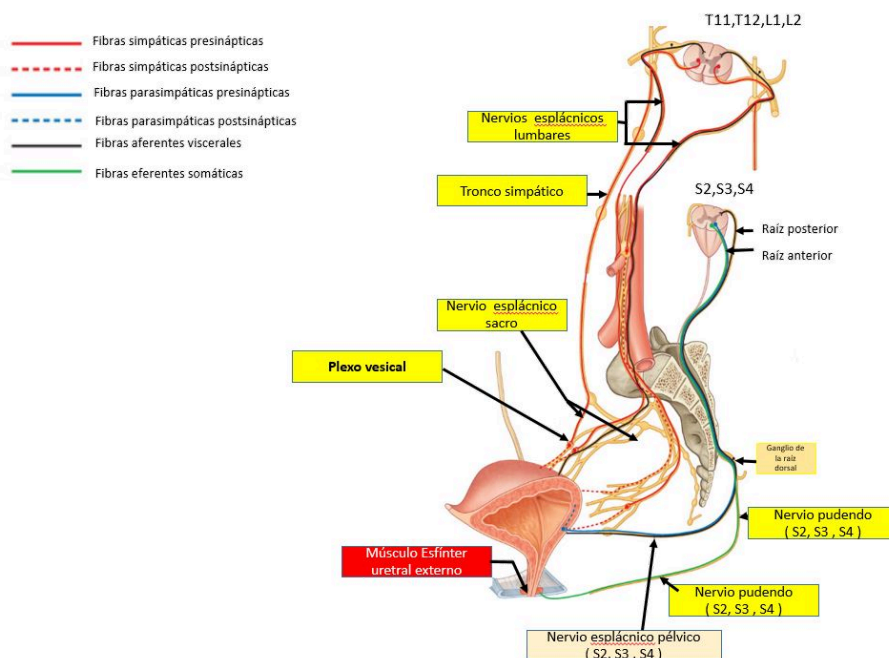
IRRIGACIÓN.



Es drenada por las **venas ilíacas internas**, y tanto en hombres como en mujeres, los vasos linfáticos de las caras supero laterales de la vejiga desembocan en los **ganglios linfáticos ilíacos externos**

INERVACION

Involucra el sistema nervioso simpático y parasimpático



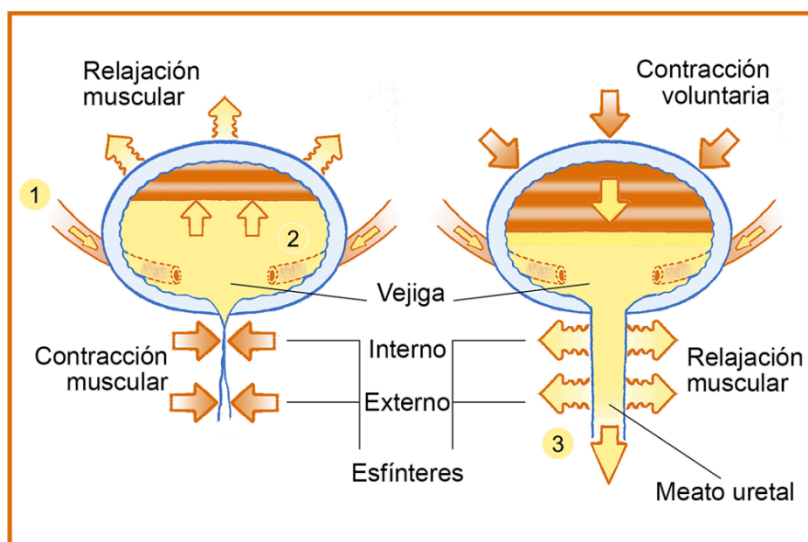
1. Las fibras simpáticas presinápticas para la vejiga urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y lumbares superiores de la médula espinal a través de los nervios espláncnicos lumbares pasando por el tronco simpático lumbar, plexo hipogástrico superior y nervios hipogástricos hacia los plexos vesicales (pélvicos). Es un subplexo del plexo hipogástrico inferior, de ahí envían fibras autónomas postsinápticas a las paredes de la vejiga urinaria.
2. Las fibras parasimpáticas presinápticas para la vejiga urinaria se originan en las neuronas de los segmentos sacros de la médula espinal S2-S4 y pasan desde los ramos anteriores de los nervios espinales sacros, a través de los nervios espláncnicos pélvicos y los plexos hipogástricos inferiores, hasta la vejiga urinaria.

RELACIONES DE LA VEJIGA:

- **PARTE ANTERIOR:**
 - Sínfisis del pubis
 - Espacio prevesical de Retzius.
 - Músculos de la pared abdominal
 - Fascia umbilicoprevesical
 - Uraco

- Vasos umbilicales obliterados
- **PARTE INFERIOR:**
 - Músculo elevador del ano
 - Músculos internos de la pelvis
- **PARTE POSTERIOR:**
 - Tiene el fondo de saco vésico rectal de Douglas y la Ampolla rectal.
- **PARTE SUPERIOR:**
 - Uréteres, Conductos Deferentes y Vesículas Seminales.

FISIOLOGIA



Los músculos de la vejiga que permiten el control voluntario de la micción y permiten 2 funciones: 1) la sensación que permite que reconozcas que tu vejiga está llena y debe ser vaciada y 2) el control motor que permite que puedas orinar voluntariamente.

Primero, como la pared vesical se estira cuando está llena o próxima a su máxima capacidad, existen señales que son transmitidas a través del sistema nervioso parasimpático para contraer el músculo detrusor, el cual es una capa de la pared vesical constituida por fibras de músculo liso que son ordenadas en fascículos longitudinales, circulares o en espiral, esta señal estimulará a la vejiga para expulsar orina a través de la uretra, luego, estas sensaciones dentro de la vejiga serán transmitidas al sistema nervioso central (SNC) por medio de fibras aferentes viscerales generales (AVG). Mientras las fibras aferentes en la cara superior de la vejiga siguen el curso de los nervios simpáticos eferentes hasta el SNC, las fibras aferentes en la porción inferior siguen a las fibras parasimpáticas eferentes.

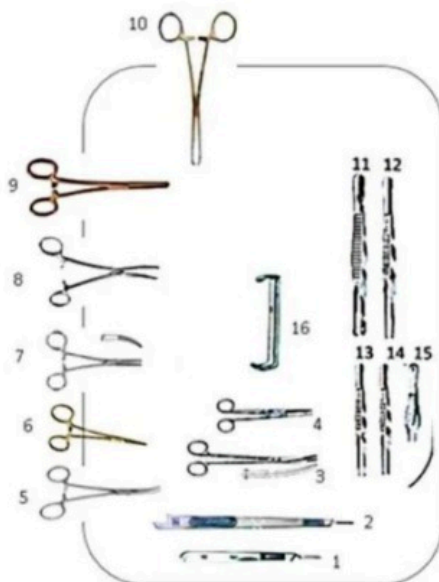


1.3. LISTA DE CHEQUEO:

INSTRUMENTAL	EQUIPOS / DISPOSITIVOS MEDICO	SUTURAS Y AGUJAS	FARMACOS Y SOLUCIONES
Equipo de general Equipo vascular Clamps Intestinales	Paquete de ropa Sonda Foley 22 x 30 Jeringa de 20 cc Gasas Caucho de succión Asepto jeringa Torundas Hoja de bisturí 15- 20 Lapicero de electro bisturí Guantes Cistoflo Equipo de venoclisis Sonda nelaton Ligasure	PIEL: Polipropileno 3/0 aguja curva cortante 3/8 de circulo TCS: Catgut cromado 3/0 aguja redonda medio círculo. FASCIA: Poliglactin 0 o 1 aguja curva redonda de ½ de circulo Seda 2/0 o 3/0 precortadas Poliglactina 910 3/0 para anastomosis	Solución salina

• ETAPA DE ORGANIZACIÓN:

- o ARREGLOS DE MESAS DE MAYO Y RESERVA (REALIZAR ESQUEMA).



1. Mango de bisturí 4 hoja 20
2. Mango de bisturí 3 hoja 15
3. Tijera de Metzembraum
4. Tijera de mayo recta
5. Pinza Kelly curva
6. Pinza Kelly recta
7. Pinza Kelly Adson
8. Pinza Rochester curva
9. Pinza Rochester recta
10. Pinza Allis
11. Pinza disección rusa
12. Pinza disección sin garra larga
13. Pinza disección con garra corta
14. Pinza disección sin garra corta
15. Pinza disección Adson con garra
16. Separadores de Farabeuf

1. Equipo general
2. Coca
3. Valva maleable
4. Deaver angosto
5. Coca con suero
6. Cánula de yankawer
7. Porta aguja
8. Sutura
9. Tijera de Metzenbaum fina
10. Tijera de mayo larga
11. Pinza de Foerster
12. Pinza de campo Backhouse
13. Compresas
14. Lápiz de electrobisturí
15. Paquete de ropa
16. Guantes
17. Caucho de succión
18. Frascos de patología





2.2. POSICIÓN DEL PACIENTE (NOMBRE Y GRÁFICO):

decúbito supino con un ligero Trendelenburg



2.3. UBICACIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO (REALIZAR GRÁFICO):



- **ETAPA DE EJECUCION:**

- **ANESTESIA (ESCRIBIR EL TIPO DE ANESTESIA):** Anestesia general





- **INCISIÓN (ESCRIBIR EL TIPO DE ABORDAJE Y EL NOMBRE DE LA INCISIÓN):**

incisión mediana infraumbilical

- **PROCESO QUIRÚRGICO (DESCRIBIR LOS PASOS PRINCIPALES DE LA TÉCNICA MÉDICO QUIRÚRGICA CON EL INSTRUMENTAL A USAR).**

TÉCNICA QUIRÚRGICA	INSTRUMENTACIÓN
Incisión en línea media desde la sínfisis del pubis hasta la proximidad del epigastrio	mango de bisturí 3 hoja de bisturí 15
Se incide el peritoneo y se levanta en tienda de campaña para acceder a la cavidad peritoneal	Tijera de Metzembraum Pinzas Electrobisturí
El peritoneo posterior es abierto sobre los vasos iliacos para exponer los uréteres.	Separador Deaver
Se disecan ambos uréteres. Su disección se prolonga cuidadosamente hacia la pelvis hasta su entrada en vejiga.	Electrobisturí
Se disea el pedículo vascular lateral vesical, de localización distal a la arteria hipogástrica	Disección vascular
Se realiza una incisión horizontal sobre el saco de Douglas, mientras se tracciona de la vejiga en sentido anterior.	
Una vez la vejiga ha sido liberada de su plano posterior, se incide a nivel del cuello vesical para su exéresis.	



Se cierra la uretra

ác. poliglicólico (DEXON®) del 0 y de 2/0

Se coloca un drenaje en el lecho quirúrgico

Jackson-Pratt

**FORMATO DE INFORME SEMANAL DE LA PRACTICA FORMATIVA
FORMATO RECORD DE ASISTENCIA A CIRUGIA - PRACTICA FORMATIVA
IQX-FT-024-UDES**